

ACOMPANHAMENTO () CONSULTA	
NS 22231697073 / 604	
ROSANA TRABALLI VENEZIANI	
IDADE: 61	PESO: 60 ALTURA: 167
SINTOMAS:	
PROFISSÃO:	
QUEIXAS:	
MEDICAMENTOS: Frixion	
MÉDICO: Dr. Francir	
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N	
EXERCÍCIO FÍSICO: musculação (3X)	
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:	
HORA QUE DORME:	HORA QUE ACORDA:
COCHILHO () SIM (X) NÃO	DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () X NA SEMANA () NÃO SO (FDS)	
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:	
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1X	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:	CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: asma MALLAMPATI: IV	IAH: SPO2:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: gastrite / prolapso (forse muito)	
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA	
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não N30i	
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA	
(S) ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS (4 hérnias lombares e cervical) Jua	
encaminhado p/ Dr. Alberto.	
09/05 - locação + marc N30	
20/05	P = 7 cmH ₂ O - Vermelho no rosto
24	IAH = 1.5 e/h -
m. de uso = 7h50' Jua	
04/09/24 P = 7 autH ₂ O	
IAH = 0,7 e/h	
m de uso: 7h6'	
fuga: 7,5 l/m Pneu adaptado	
Natacha	
09/10/24 P = 7,2 cmH ₂ O	
IAH = 1,3 e/h	
m de uso: 6h49'	
fuga: 6,3 l/m Natacha	
12/05 P = 7.2 cmH ₂ O	
IAH = 1.1 e/h	
m. de uso: 7h42'	
fuga = 10.9 epur. Jua.	
traco pl o prong nasal, pillow	

30/01/25 $P=7,2 \text{ au H}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 14 \text{ e/h}$
unde uso: 6h 25'
freq: 7,9 l/m

Beu adaptada

Natasha

Nome: ROSANA TRABALLI VENEZIANI
Data de Nascimento: 20-6-1962
IMC: 21,26
Sexo: Feminino
Data do exame: 10-07-2020

Peso: 60 kg
Altura: 1,68 m
Médico: DR. FRANCIR VENEZIANI SILVA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 10-07-2020, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 556,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 201,0 e 205,0 minutos. O tempo total de sono foi de 302,0, eficiência de 54,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,6%; estágio N2: 60,3%; estágio N3: 21,0%; sono REM: 15,1%. O índice de despertares foi de 4,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 3,8, sendo elas 4 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 15 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e mínima de 87%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 59 - 84 bpm e NREM de 59 - 89 bpm.

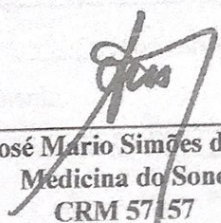
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 3,8/hora; ✓
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=87%); ✓
5. latências para o sono prolongadas;
6. número de despertares breves normal;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (4,4/hora);
8. registro de ronco moderado durante o sono.

Exame evidenciando roncopia primária.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.157